

КҰЖЖ бойынша ұйым коды 388338080000 Код организации по ОКПО 388338080000		
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	ҚР ДСМ «ТРАВМАТОЛОГИЯ ЖӘНЕ ОРТОПЕДИЯ ҒЗИ» ШЖҚ РМК 010000, г. Астана пр. Абылай хана 15а	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы «23» қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 027 / е нысанды медициналық құжаттама
РГП на ПХВ "НИИТО" МЗ РК		Медицинская документация Форма № 027 / у Утверждена приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от «23 » ноября 2010 года №907

ВЫПИСКА

из медицинской карты № 6592

стационарного больного

Кошірме жіберілген ұйымның атауы мен мекенжайы (название и адрес организации куда направляется выписка)

ГКП на ПХВ "Ерейментауская РБ" при УЗ Акмолинской области

Науқастың тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество больного): АЛЬБЕКОВ ТЕМИРЛАН РУСЛАНОВИЧ

Туған күні (Дата рождения): 21.10.2016

Үйінің мекенжайы (Домашний адрес): ОБЛАСТЬ: Акмолинская, РАЙОН: Ерейментауский, СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ:

Тургайский, АУЛ(СЕЛО): Тургай

Жұмыс орны мен кәсібі (Место работы и род занятий): Ясли сад "Бөбекжай Әмина" младшая группа

Ауруханаға түскен күні (Дата госпитализаций): 15.07.2019 16:00

Ауруханадан шыққан күні (Дата выписки): 01.08.2019 17:00

Клинический диагноз: Q76.3Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости

Врожденный сколиоз грудного позвоночника на фоне нарушение формирования позвоночника. Клиновидный Тn9 позвонок.

Реберный горб слева.

Осложнения:

Расшифровка осложнения:

Сопутствующие заболевания:

Расшифровка сопутствующих заболеваний:

Жалобы при поступлении: Госпитализирован в плановом порядке с жалобами на прогрессирование деформации позвоночника, на быструю утомляемость и спотыкание при ходьбе.

Анамнез заболевания: Со слов мамы, ребенок более с рождения. Деформацию заметили в возрасте 1 года. После обследования выявлено врожденное аномалия развития позвоночника. Не лечился. В связи с чем 07.06.2019 проконсультирован в НИИТО, ортопедом-вертебрологом Абдалиевым С.С., рекомендовано госпитализация в плановом порядке через портал госпитализации, на оперативное лечение. Данная госпитализация в отделение ортопедии № 6 для дальнейшей решения тактики лечения.

Анамнез жизни: Болезнь Боткина, туберкулез, вен. заболевания отрицает. Со слов на Д-учете у специалистов состоит по поводу основного заболевания.

Аллергоанамнез: Аллергологический анамнез – со слов не отрицает.

Эпидемиологическое окружение чистое.

Объективное состояние при поступлении: Общее состояние удовлетворительное. Нормального питания. Кожные покровы, видимые слизистые физиологической окраски, чистые. Дыхание прослушивается по всем полям, везикулярное, хрипов нет. ЧДД = 20 в', перкуторно – легочный звук. Тоны сердца приглушены. Пульс ритмичный 115 ударов в минуту, АД 90/60 мм рт. ст. Язык чистый, влажный. При пальпации живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Симптом поколачивания отрицателен с обеих сторон. Физиологические оправления в норме.

Neurostatus: Контактен. Адекватен. Ориентирован. Зрачки OD=OS, фотореакция живая. Менингеальных знаков нет. Функции тазовых органов не нарушены. Нарушения чувствительности нет.

Статус: При осмотре передвигается самостоятельно, без дополнительных средств опоры. Во фронтальной плоскости определяется деформация верхнегрудном отделе позвоночника с выпуклостью влево. Также определяется асимметрия лопаток, надплечий. Положителен симптом Адамса. Сагитальный баланс сохранен. При пальпации незначительная болезненность грудном отделе позвоночника. Сосудистых и неврологических нарушений нет.

Инструментальные методы исследования: ЭКГ от 10.07.2019 Синусовый ритм, ЧСС 119 уд в мин; ЭОС отклонено вправо.

УЗИ ОБП от 12.06.2019 Признаки перегиба желчного пузыря.

ЭхоКГ от 19.06.2019 Заключение: Полости сердца не расширены. Удовлетворительная систоло-диастолическая функция ЛЖ. Толщина миокарда ЛЖ в норме.

КТ груднопоясничного отдела позвоночника от 26.04.2019 Заключение: КТ признаки сколиоза влево, клиновидного полупозвонок Тn 10 слева грудного отдела позвоночника. Рентген. 17.07.2019 11:17. Фронтально отмечается угловое искривление позвоночного столба на 20 градусов с вершиной в Тn11. Сагитально без искривления.

Таз без костной патологии.

Доза облучения;

Рентген. 25.07.2019 14:18. Однопластинчатый эндокорректор закреплён на уровне Тn8-12. Фронтально отмечается устранение деформации позвоночника.

Доза облучения;

Лабораторно-диагностические исследования: Анализы до операции:

Группа крови: АВ(IV) четвертая
Резус фактор: Rh(+) Положительный

ОАК от 10.07.2019 Гемоглобин 133 г/л; Лейк 6,1; СОЭ 11 мм/час; Тромб 260;
ОАМ от 10.07.2019 с/желтый; прозрачная; Сахар отр; Белок отр; Лейк ед в п/зр; Плоский эпите 2-4 в п/зр.
БХАК от 10.07.2019 Общий белок 53; Глюкоза 4,8; АЛТ 0,03;
Микрореакция от 10.07.2019 №6215 отр.
Гепатиты от 17.06.2019 №20316 отр.
ВИЧ от 17.06.2019 №37163 отр.
Группа крови и резус-фактор(17.07.2019 16:21 №4928):
Группа крови АВ(IV); Резус фактор Rh+; Антитела не установлено;

Коагулологические исследования крови №1(17.07.2019 14:01 №3077):
ПТИ 13,1-1,00 %; МНО 0,99; Фибриноген-А 3,4 г/л; РФМК 4,5;

Анализ мочи(17.07.2019 13:57 №5947):

Цвет с/жел; Прозрачность полная; Относительная плотность 1020; реакция 5,0; Белок 0,12 г/л; Глюкоза отр; Билирубин -;
Уробилиноиды -; Кетоны -; Плоский эпителий 0-0-1 в п/з; Лейкоциты 0-1 в п/з; Эритроциты 2-3 в п/з; Слизь +++;

Биохимический анализ крови (7 параметров)(17.07.2019 12:16 №3464/9):

Общий белок 67 г/л; АЛТ 16 ед/л; АСТ 39 ед/л; Билирубин общий 12 мкмоль/л; Креатинин 30 ммоль/л; мочевина 3,75 ммоль/л;

Общий анализ крови(17.07.2019 11:56 №5845):

Лейкоциты 5,6; Эритроциты 5,3 10^{12} /л; Гемоглобин 124 г/л; Гематокрит 38,5 %; MCV 72,5; MCH 23,4; MCHC 32,2;
Тромбоциты 240 10^9 /л; Сегментоядерные нейтрофилы 39,7; Лимфоциты 44,6; Моноциты 10,4; Эозинофилы 5,1; Базофилы 0,2; СОЭ 10 мм/саг(час);

Анализ после операции:

Анализ мочи(24.07.2019 14:50 №6168):

Цвет сол/желт; Прозрачность полная; Относительная плотность 1020; реакция 5,5; Белок 0,25 г/л; Глюкоза отр.;
Лейкоциты 1-2 в п/з; Эритроциты 0-1 в п/з; Соли ураты ++; Соли мочевой кислоты +;

Общий анализ крови(24.07.2019 12:41 №6079):

Лейкоциты 6,7; Эритроциты 4,3 10^{12} /л; Гемоглобин 102 г/л; Гематокрит 32,1 %; Тромбоциты 244 10^9 /л; Сегментоядерные нейтрофилы 50,7; Лимфоциты 35,7; Моноциты 11,8; Эозинофилы 1,8; Базофилы 0,0; СОЭ 32 мм/саг(час);

Коагулологические исследования крови №1(24.07.2019 12:26 №3169):

ПТИ 13,1-1,00 %; МНО 0,99; Фибриноген-А 4,3 г/л; РФМК 7,5; АЧТВ 31,0 сек; Тромбиновое время 17,7 сек;

Общий анализ крови(23.07.2019 06:35 №6528):

Лейкоциты 7,02; Эритроциты 4,2 10^{12} /л; Гемоглобин 97 г/л; Гематокрит 30 %; MCV 71,1; MCH 23,2; MCHC 32,7;
Тромбоциты 251 10^9 /л; Сегментоядерные нейтрофилы 52,6; Лимфоциты 32,5; Моноциты 14,2; Эозинофилы 0,6; Базофилы 0,1; СОЭ 22 мм/саг(час);

Коагулологические исследования крови №1(22.07.2019 18:33 №3359):

ПТИ 14,6"-0,80 %; МНО 1,13; Фибриноген-А 2,35 г/л;

Общий анализ крови(22.07.2019 18:19 №6518):

Лейкоциты 11,4; Эритроциты 4,12 10^{12} /л; Гемоглобин 96 г/л; Гематокрит 29,6 %; MCV 71,8; MCH 23,3; MCHC 32,4;
Тромбоциты 257 10^9 /л;

Консультации специалистов: Педиатр от 10.07.2019 Эпид окружение чистое.

Детский кардиолог от 19.06.2019 Открытое овальное окно 2 мм ДХЛЖ. Противопоказаний к проведению оперативного лечения на момент осмотра нет.

19-07-2019 Совместный осмотр с зав отд Абдалиевым С.С., Рекомендовано оперативное лечение в объеме коррекция сколиоза эндокорректором. Удаление полупозвонка

23-07-2019 Реабилитолог Диагноз: Врожденный сколиоз грудного позвоночника на фоне нарушение формирования позвоночника. Клиновидный Th9 позвонок.

Реберный горб слева.. Коррекция деформации позвоночника эндокорректором. Частичная экстерпация Th9 полупозвонка. Задний спондилодез.

Реабилитация 1 этапа. Рекомендации: Лечебная гимнастика для тренировки мышц спины и поясницы №5 Ингляции с Амбро №5

30-07-2019 Реабилитолог Диагноз: Врожденный сколиоз грудного позвоночника на фоне нарушение формирования позвоночника. Клиновидный Th9 позвонок.

Реберный горб слева. Коррекция деформации позвоночника эндокорректором. Частичная экстерпация Th9 полупозвонка. Задний спондилодез. Реабилитация 1 этапа. Рекомендации: Продолжить медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях по месту жительства.

Операции: 81.052 Спондилодез грудного и поясничного позвонков, задний доступ, с внутренней фиксацией эндокорректорами Коррекция деформации позвоночника эндокорректором. Частичная экстерпация Th9 полупозвонка. Задний спондилодез. 22.07.2019

Исход операции благоприятный

Полученное лечение: 1. Ибупрофен 5 мл внутрь(1р. в д. №6) 1 раз(а) в день. №6

2. Режим стационарный. Диета №15 стол. (1р. в д. №7) 1 раз(а) в день. №15

1. Подготовить к операции, очистительная клизма(1р. в д. №1) 1 раз(а) в день. №1
4. Цефазолин 500мг+ NaCl 0,9% - 100,0 мл в/в капельно(2р. в д. №4) 2 раз(а) в день. №2
5. промедол 2 % 0,2 мл в/в дробно №1 1.0
6. ЛГ индивидуальная 5
7. ингаляции 5

Инфузионно-трансфузионная программа:

Дата и время - 22.07.2019 10:39, Препараты - физ р-р 0,9%, Доза(мл) - 250,0, В составе раствора - , Н/фл - , Скорость (мл/ч) - , Перелито (мл) - 250

Состояние при выписке: Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет.

Объективно: Температура тела в пределах нормы. Кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски. Дыхание самостоятельное, при аускультации прослушивается с обеих сторон везикулярное, хрипов нет. ЧДД 20 в мин. Пульс ритмичный. АД 105/65 мм.рт.ст. Тоны сердца приглушены. ЧСС -110 в'. Язык чистый, влажный. При пальпации живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Физиологические опрвления в норме.

Локальный статус: Пациент передвигается самостоятельно. Грудно-поясничный отдел фиксирована корсетом. На перевязке послеоперационная рана без признаков воспаления, зажила первичным натяжением, швы удалены. Произведена замена асептической повязки. Сосудистых и неврологических нарушений в нижних конечностях нет.

После операции деформация позвоночника устранена, отмечает купирование болевого синдрома.

Курс лечения закончен, пациентка с улучшением выписывается для дальнейшего амбулаторного лечения и наблюдения.

Емдік және еңбек ұсынымдары (Лечебные и трудовые рекомендации): 1. Наблюдение травматолога – ортопеда, педиатра по месту жительства.

2. Ограничение физических нагрузок:

3. Ношение корсета при длительных физических нагрузках, ходьбе, обострении болевого синдрома.

4. Санаторно-курортное лечение.

5. Продолжить курс ЛГ, ЛФК, ФТЛ по месту жительства в поликлинике.

6. Реабилитационное лечение через 3-4 месяца после операции!

7. Консервативное лечение 2 раза в год амбулаторно по месту жительства.

8. Профилактика травматизма, избегать переохлаждений.

9. Консультация вертебролога через каждые 6 месяцев для наблюдения динамики

Лечащий врач:

БАЙТОВ ДАУЛЕТ ТОБЖАНОВИЧ

Заведующий отделением:

АБДАЛИЕВ СЕЙДАЛИ САПАРАЛИЕВИЧ

